①腹股沟韧带下方经股管向卵圆窝突出
②疝块小呈半球形，咳嗽冲击感不明显
③中老年肥胖女性多见股管太小，压力传不过来
④最易嵌顿（不鸣则已一鸣惊人）
股管很小

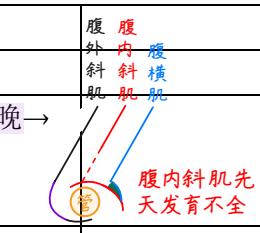
二、股疝

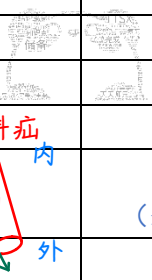
①嵌顿：急症手术复位，不满足没大事
②绞窄：单纯疝囊高位结扎，不急症修补
若肠管坏死→切除
③手术：无张力疝修补（热死了）
腹腔镜的疝修补
McVay法

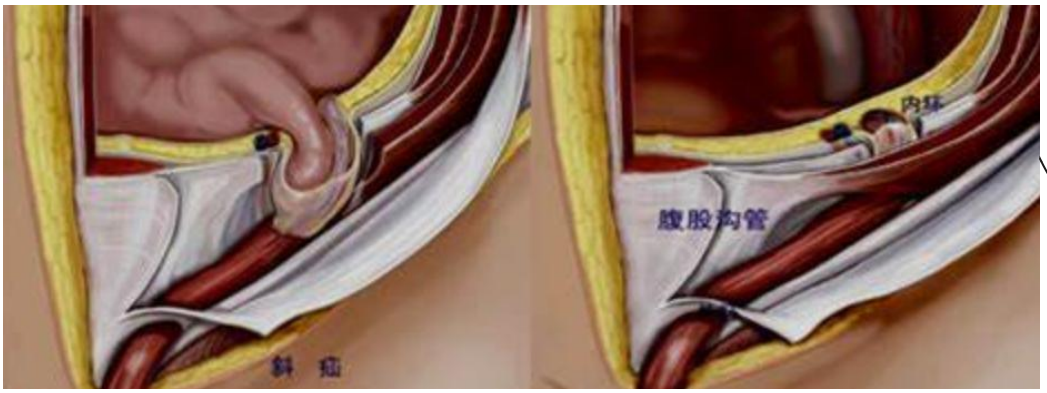


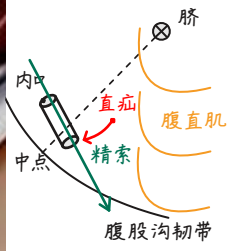
三、腹股沟疝

ttsx	斜疝	直疝
发病率	最常见	少见
机制	鞘突不闭锁或闭锁不全（右侧睾丸下降较晚→右侧多见又来晚了） 腹内斜肌等先天发育不全或后天腹壁薄弱	
好发	儿童、青年男性	老年男性
突出途径	经腹股沟管内口	经海氏/Hesselbach 三角
回纳疝块后压住内口	疝块不再突出（鉴别关键）	疝块仍可突出
疝块外形	椭圆或梨形、呈蒂柄状	半球形、基底较宽
进入阴囊/大阴唇	多√	几乎×
咳嗽冲击感	多√（小孩子咳嗽就很害怕）	几乎×
精索/子宫圆韧带	在疝囊后方 （小孩喜欢滑梯-精索是滑梯）	在疝囊前外方 （老直男喜欢顶-把精索顶出来）
疝囊颈在腹壁下动脉	外侧	内侧
嵌顿几率	多	少









胎儿时期睾丸从腹腔逐渐下降到阴囊，推动相应腹膜一起下降，称为鞘膜（睾丸表面腹膜脏壁两层形成鞘膜腔，出生后鞘膜腔闭合形成鞘膜突，鞘膜未闭合导致：①腹股沟斜疝②鞘膜腔积液）

四、鉴别

1.隐睾（阴囊空虚感）

1 岁内	自行下降（等一等）
1 岁后	短期用 hCG（催一催-h 后 c 催 g 睾）
2 岁前	睾丸固定术（最多等你到 2 岁）
睾丸萎缩+对侧睾丸正常	切除未降睾丸
双侧睾丸不能下降	睾丸自体移植术